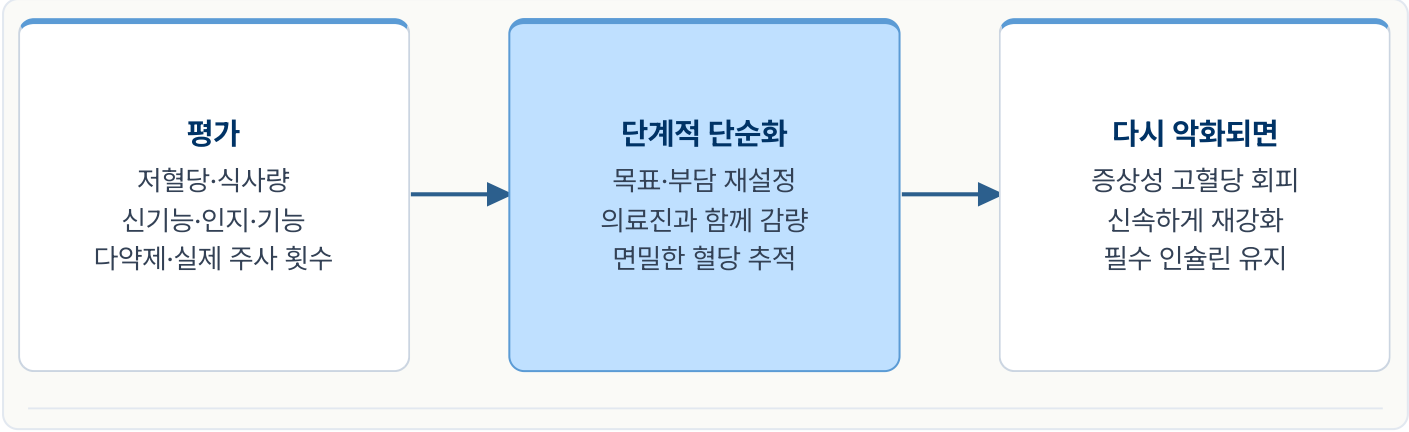
의료진 진료 카드 · ASL-045

고령·취약 당뇨병, 치료 부담 줄이기

탈강화는 목표를 안정적으로 달성한 뒤 목적을 정해 약제를 줄이거나 단순화하는 과정이다.

탈강화와 재강화를 하나의 계획으로



연자 Q&A · 목표는 나이와 기능을 함께

건강·기능 양호	고령이라도 HbA1c는 대개 7.0~7.5% 미만을 제시했다.
다질환·취약·인지/기능 저하	HbA1c <8.0% 정도로 완화 가능. 매우 복잡한 건강상태는 수치 자체보다 저혈당·증상성 고혈당 회피가 우선이다.

본강의 · 감량 대상과 유지 대상

감량 목적	안정된 개별 목표 달성 후 저혈당·약물 부작용·치료 부담을 줄인다. 생활습관과 자기관리 교육을 지속하며 단계적으로 시행한다.
장기 보호 약제	CKD/HF의 SGLT2i, ASCVD/뇌졸중 이득의 GLP-1 RA는 적응증이 지속되면 HbA1c 호전만으로 중단하지 않는다.
췌도부전	혈당이 조절되어도 생명 유지에 필요한 저용량 인슐린을 계속한다.

본강의 · 식사 감소와 CKD의 위험

SU	고령·식사 불량·진행된 CKD에서 저혈당 위험이 크다. 포도당으로 일시 회복해도 수일 동안 저혈당이 반복될 수 있다.
Metformin	eGFR <30 mL/min/1.73m²는 중단. 30~45에서는 신규 시작에 주의하고, 강의에서는 가급적 최대 1,000mg/day 이하를 제시했다.

환자가 스스로 줄이는 방식으로 안내하지 않는다. 단계적 감량과 면밀한 모니터링, 악화 시 신속한 재강화를 함께 설명한다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 당뇨병 update(민세희)
교재 PDF 149–150·152쪽 · 본강의 0:12:05–0:13:56, 0:18:28–0:20:00 · 연자 Q&A 60쪽
광교바른내과 · 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 진료 카드 · ASL-045

혼합형·다회주사에서 단순 요법으로

연자 Q&A의 취약 노인 증례를 실제 투여량과 저혈당 위험에 연결한다.

처방량과 실제 투여량을 먼저 맞춘다

실제 사용 확인
독거·인지 저하
반복 저혈당
주사·혈당 측정 가능성

→

기저 1회 전환 검토
Degludec(트레시바)
Glargine U300(투제오)
보수적 시작

→

추적 후 조정
저혈당·증상성 고혈당
가능하면 CGM 활용
상태에 따라 재강화

연자 Q&A · 전환을 제안한 상황

증례 맥락	독거·인지 저하·저혈당 쇼크. 다파시타엠서방정 5/50/500 하루 1회 + Humalog Mix 25 24 U 하루 2회 때 HbA1c 5.7%. 16 U 하루 2회로 감량한 뒤 HbA1c 7.5%였으나 실제로는 하루 1회 주사한 경과였다.
전환 의견	혼합형 하루 2회보다 장시간형 기저인슐린 하루 1회로 단순화하는 것이 적절하다는 답변이었다.

연자 Q&A · 감량률의 적용 맥락

약 20% 감량	기존 총량을 그대로 옮기지 않고 저혈당 병력 때문에 약 20% 줄여 보수적으로 시작한다는 해당 증례 답변이다.
목표와 관찰	HbA1c 약 8% 또는 더 취약하면 저혈당·증상성 고혈당 회피. 가능하면 CGM을 활용한다. 실제 사용량과 혈당 추세를 함께 판단한다.

연자 Q&A · 경구 전환과 잔여 분비능

소량 기저 유지 중	93세·10 U 유지 사례에서 C-peptide로 잔여 분비능을 보도록 제안했다. 분비능 유지 시 저혈당 위험이 낮은 경구약으로 전환하며 감량·중단을 고려한다.
유지 쪽의 단서	C-peptide가 매우 낮거나 인슐린 중단 시 혈당이 빠르게 악화되면 소량 기저인슐린 유지가 더 적절하다는 연자 의견이다.

약 20%는 이 Q&A 증례의 보수적 시작 의견이다. 혼합형의 처방 총량만으로 새 기저인슐린 용량을 자동 산출하지 않고 실제 투여 경과를 함께 본다.